

Cotard Sendromu

Cotard Sendromu, kişinin kendi bedeni, varlığı veya yaşamıyla ilgili gerçeklikle bağdaşmayan nihilist sanrılar geliştirmesiyle karakterize, nadir görülen bir psikopatolojik sendromdur. “Yürüyen ceset sendromu” olarak da bilinen bu durumda kişi yalnızca öldüğüne inanmakla kalmayabilir; organlarının kaybolduğunu, vücudunun çürüdüğünü, bedeninin artık var olmadığını veya kendisinin tamamen yok olduğunu düşünebilir. Bazı olgularda bu inançlar kişinin kendi varlığıyla sınırlı kalmaz ve çevresindeki insanların da ölü olduğuna veya artık var olmadıklarına inanmasına kadar genişleyebilir. Bu nedenle Cotard Sendromu, basitçe “ölü olduğunu düşünmekten” çok daha kapsamlı bir benlik ve varoluş bozukluğu olarak değerlendirilebilir.

Sendrom ilk olarak Fransız nörolog ve psikiyatrist Jules Cotard tarafından 1882 yılında *délire de négation* (inkâr sanrısı) olarak tanımlanmıştır. Günümüzde Cotard Sendromu, DSM-5 veya ICD-11 içerisinde bağımsız bir psikiyatrik tanı olarak yer almamakta; çeşitli psikiyatrik, nörolojik ve tıbbi durumlar sırasında ortaya çıkabilen fenomenolojik bir sendrom olarak kabul edilmektedir. En sık şiddetli depresif tablolarla ilişkilendirilmekle birlikte şizofreni spektrum bozuklukları, bipolar bozukluk, deliryum, nörobilişsel bozukluklar ve bazı nörolojik hastalıklarla da birlikte görülebilir. Beyin hasarı, epilepsi, tümörler ve diğer organik beyin hastalıklarının eşlik ettiği vakalar da bildirilmiştir.

Cotard Sendromu'nun klinik görünümü oldukça değişkendir. En karakteristik özellik, nihilist sanrılardır. Hasta “Ben öldüm”, “Organlarım yok”, “Kalbim çalışmıyor”, “Bedenim artık mevcut değil” veya “Zaten çürüdüm” gibi düşüncelere kesin biçimde inanabilir. Bazı hastalarda bedenlerinin yandığı, parçalandığı veya içerisindeki organların ortadan kaybolduğu şeklinde olağandışı bedensel deneyimler de görülebilir. Daha ileri durumlarda kişi yalnızca kendisinin değil, çevresindeki insanların da ölü olduğuna inanabilir. Örneğin bir vaka raporunda hasta, karşısındaki doktorun ve aynı odadaki diğer hastaların zaten öldüğünü ileri sürmüştür. Bu durum, Cotard fenomeninin yalnızca “kendini ölü olarak görme” ile sınırlı olmadığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Cotard Sendromu sıklıkla depresyon, kaygı, suçluluk, sosyal geri çekilme, ajitasyon, halüsinasyonlar ve intihar düşünceleri ile birlikte ortaya çıkabilir. Özellikle kişinin gerçekten ölü olduğuna inanması, yaşamını sürdürmek için yemek yemeyi veya kendisine bakım sağlamayı gereksiz görmesine yol açabilir. Bu nedenle sendrom klinik açıdan ciddi bir durumdur ve kendine zarar verme, öz bakımın ihmal edilmesi ve intihar davranışı açısından dikkatli değerlendirme gerektirir.

Sendromun neden ortaya çıktığı henüz tam olarak açıklanamamıştır. Mevcut çalışmalar, frontal ve temporal bölgeler, parietal alanlar, limbik sistem ve insula gibi benlik algısı, beden farkındalığı, duygusal işleme ve gerçeklik değerlendirmesinde rol oynayan beyin ağlarındaki işlev bozukluklarının etkili olabileceğini düşündürmektedir. Özellikle interosepsiyon adı verilen ve kişinin kalp atışı, beden içerisindeki duyumlar ve diğer içsel sinyalleri algılamasını sağlayan süreç üzerinde durulmaktadır. Bu görüşe göre kişi kendi bedeninden ve içsel duyumlarından beklenen duygusal “canlılık” hissini alamadığında, bu olağandışı deneyimi açıklamak için “ölmüş olmalıyım” şeklinde bir nihilist sanrı geliştirebilir. Ancak bu mekanizmalar henüz kesin olarak kanıtlanmış değildir.

Cotard Sendromu için tek ve özgül bir tedavi bulunmamaktadır. Tedavi, sendroma eşlik eden altta yatan psikiyatrik veya nörolojik durumun belirlenmesine ve buna yönelik müdahaleye dayanır. Antipsikotikler, antidepressanlar ve gerektiğinde diğer psikiyatrik tedaviler kullanılabilir. Özellikle şiddetli depresyon ve belirgin psikotik belirtilerin bulunduğu olgularda elektrokonvülsif terapi (EKT) etkili bir seçenek olarak bildirilmiştir. Bununla birlikte, organik bir neden veya deliryumdan şüpheleniliyorsa nörolojik ve tıbbi

değerlendirme de mutlaka yapılmalıdır.

Sonuç olarak Cotard Sendromu, kişinin “Ben kimim, bedenim gerçekten var mı ve hayatta mıyım?” gibi en temel varoluşsal deneyimlerinin bozulabildiği sıra dışı bir psikopatolojik tablodur. Hastanın “Ben öldüm” şeklindeki ifadesi ilk bakışta yalnızca tuhaf bir düşünce gibi görünse de, altında beden algısının, duygusal deneyimin, benlik hissinin ve gerçeklik değerlendirmesinin ciddi biçimde bozulduğu karmaşık bir süreç bulunabilir. Bu nedenle Cotard Sendromu, hem psikiyatri hem de nörobilim açısından benlik ve gerçeklik algısının nasıl oluştuğunu anlamak için dikkat çekici bir klinik pencere sunmaktadır.

Kaynaklar:

- 1) Bistas K, Mirza M. Walking Corpse Syndrome: A Case Report of Cotard's Syndrome. *Cureus*. 2024 Jul 4;16(7):e63824. doi: 10.7759/cureus.63824. PMID: 39099940; PMCID: PMC11297383.
- 2) Flach R, Varga JÉ, Herold R, Bányavölgyi V, Osvath P, Fekete S, Voros V, Tényi T. Case Report: Cotard's syndrome associated with suicide attempt-related delirium. *Front Psychiatry*. 2026 Jul 3;17:1890939. doi: 10.3389/fpsyt.2026.1890939. PMID: 42491005; PMCID: PMC13375714.
- 3) Koreki A, Mashima Y, Oda A, Koizumi T, Koyanagi K, Onaya M. You are already dead: Case report of nihilistic delusions regarding others as one representation of Cotard's syndrome. *PCN Rep*. 2023 May 21;2(2):e93. doi: 10.1002/pcn5.93. PMID: 38868142; PMCID: PMC11114400.

Ali Bocakkıtay/ Founder, Wionpav Labs/ Medical Student, Faculty of Medicine, Selçuk University